Bilan biologique — normes françaises

Valeurs usuelles de l'adulte en unités SI, cible INR sous AVK fixée par le prescripteur, pièges d'unités et repères infirmiers, pour réviser en IFSI

Clairance

Référentiel 2026 (entrant.e.s à partir de septembre 2026) : UE en lien, UE B.1 « Sciences biomédicales » (S1, S2) et UE B.3 « Pratiques et interventions infirmières » (examens biologiques en S1, prélèvement veineux en S2), selon l'offre de formation publiée par l'Université de Bourgogne Europe

⚠ PIÈGE Les valeurs usuelles varient selon les laboratoires
Interpréter un résultat avec les valeurs imprimées sur **le compte rendu du laboratoire**. Celles-ci viennent d'un référentiel national publié (adulte), pour réviser.

Valeurs usuelles de l'adulte

Examen	Milieu	Valeurs usuelles	Autre écriture
Ionogramme et calcium			
Sodium (Na^+)	Pl	135–145 mmol/L	
Potassium (K^+)	Pl	3,5–4,5 mmol/L	
Chlorure (Cl^-)	Pl	95–105 mmol/L	
Bicarbonates (HCO_3^-)	Pl	23–27 mmol/L	
Calcium total	Se ou Pl	2,20–2,60 mmol/L	88–104 mg/L
Rein			
Urée	Se ou Pl	2,5–7,5 mmol/L	0,15–0,45 g/L
Créatinine, homme	Se ou Pl	60–115 µmol/L	7–13 mg/L
Créatinine, femme	Se ou Pl	45–105 µmol/L	5–12 mg/L
Clairance de la créatinine (pour 1,73 m²)		1,50–2,30 mL/s	90–140 mL/min
Glucose			
Glucose	Pl	3,90–5,50 mmol/L	0,70–1,00 g/L
HbA1c (part de l'Hb totale)	Sg	< 0,06	< 6 %
NFS (hémogramme)			
Hémoglobine, homme	Sg	130–170 g/L	
Hémoglobine, femme	Sg	120–160 g/L	
Hématocrite, homme	Sg	0,42–0,54	42–54 %
Hématocrite, femme	Sg	0,37–0,47	37–47 %
Hématies, homme	Sg	4,5–5,7 T/L	
Hématies, femme	Sg	4,2–5,2 T/L	
Leucocytes	Sg	4,0–10,0 G/L	
Polynucléaires neutrophiles	Sg	2–7,5 G/L	
Plaquettes	Sg	150–450 G/L	
Hémostase			
Taux de prothrombine (TP)	Pl	70–130 %	
TCA (rapport malade/témoin, sans unité)	Pl	0,80–1,20	
Fibrinogène	Pl	2–4 g/L	
Inflammation			
CRP (protéine C réactive)	Se	< 5 mg/L	
Bilan hépatique et protéines			
ASAT	Se	< 35 UI/L	
ALAT, homme	Se	< 45 UI/L	
ALAT, femme	Se	< 34 UI/L	
GGT, homme	Se	< 55 UI/L	
GGT, femme	Se	< 38 UI/L	
Bilirubine totale	Se ou Pl	< 17 µmol/L	< 10 mg/L
Albumine	Se	38–48 g/L	
Protéines totales	Se	65–80 g/L	
INR sous AVK : cible fixée par le prescripteur			
INR sous AVK, cible la plus courante		2–3	
INR sous AVK, certaines valves mécaniques		3–4,5	

Milieu : Pl plasma, Se sérum, Sg sang. « Autre écriture » : seconde unité donnée par la source (équivalence arrondie). G/L = 10^9/L ; T/L = 10^{12}/L. Valeurs indicatives : elles varient selon le laboratoire.

Fonction rénale : le DFG estimé

Le **DFG estimé** (DFGe) se calcule à partir de la créatininémie (formule CKD-EPI chez l'adulte, recommandée par la HAS) et s'exprime en mL/min/1,73 m². DFGe < 60 pendant plus de 3 mois : maladie rénale chronique de stade 3 ou plus. Au-dessus de 90 : DFG normal ou augmenté (stade 1 si marqueurs d'atteinte rénale).

Pièges d'unités

⚠ PIÈGE Même examen, deux unités
La même glycémie s'écrit 3,90–5,50 mmol/L ou 0,70–1,00 g/L ; la créatinine (homme) 60–115 µmol/L ou 7–13 mg/L. Lire l'unité avant de comparer un résultat à une norme.

⚠ PIÈGE Fraction ou pourcentage
Hématocrite 0,42 = 42 % ; HbA1c < 0,06 = < 6 %. Même valeur, deux écritures (× 100).

⚠ PIÈGE TP, INR, TCA : trois écritures
TP en %, INR sans unité, TCA en **rapport** malade/témoin. Ne pas comparer un TP à une cible d'INR.

✓ EXEMPLE Deux calculs
TCA : 45 s ÷ 30 s = 1,50 (au-dessus de 1,20).
Clairance : 1,50 mL/s × 60 = 90 mL/min.
Valeurs d'exercice (TCA), pas des résultats de patient.e.

Repères infirmiers

+ NOTE CLINIQUE Kaliémie élevée et hémolyse
Signaler d'abord une kaliémie élevée, selon le protocole du service. Une hémolyse du prélèvement peut donner une fausse hyperkaliémie : un contrôle au laboratoire, sans garrot, peut être demandé. Il ne retarde pas le signalement.

+ NOTE CLINIQUE INR sous AVK
La cible est fixée par le prescripteur selon l'indication : 2 à 3 le plus souvent, 3 à 4,5 pour certaines valves mécaniques. Au-dessus de la cible : risque de saignement (surdosage possible), à signaler selon le protocole.

Sources : Conseil scientifique des concours de l'internat en pharmacie, « Valeurs biologiques usuelles », V8 (19.11.2009), diffusé par le CNG ; VIDAL Recos « AVK (traitement par) » (21.10.2025) ; VIDAL, estimation du DFG (2022) ; La Revue du Praticien (stades de MRC, 2022 ; hyperkaliémie, 2026).

Rédaction assistée par IA ; contenu vérifié et validé par le vendeur. · Outil de révision. Il complète vos cours et ouvrages de référence, il ne les remplace pas. · Ne remplace ni les protocoles de votre service, ni la prescription médicale, ni l'avis d'un.e professionnel.le de santé.